

Diarreia e disfunção gastrointestinal no doente crítico

Professor (a):

Paula S. Mesquita

Intensivista pelo HCFMUSP

Diarista da UTI da Gastroenterologia do HCFMUSP



Trato gastrointestinal - funções :

Digestão e Nutrição

Endócrina

Imune

Barreira



Trato gastrointestinal - funções :

Digestão e Nutrição

Endócrina

Imune

Barreira

Preciso de:

- Boa perfusão
- Motilidade



Trato gastrointestinal + UTI :

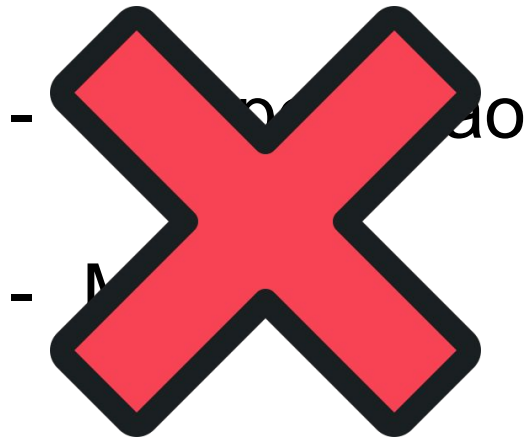
Preciso de:

- Boa perfusão
- Motilidade



Trato gastrointestinal + UTI :

Preciso de:



Choque

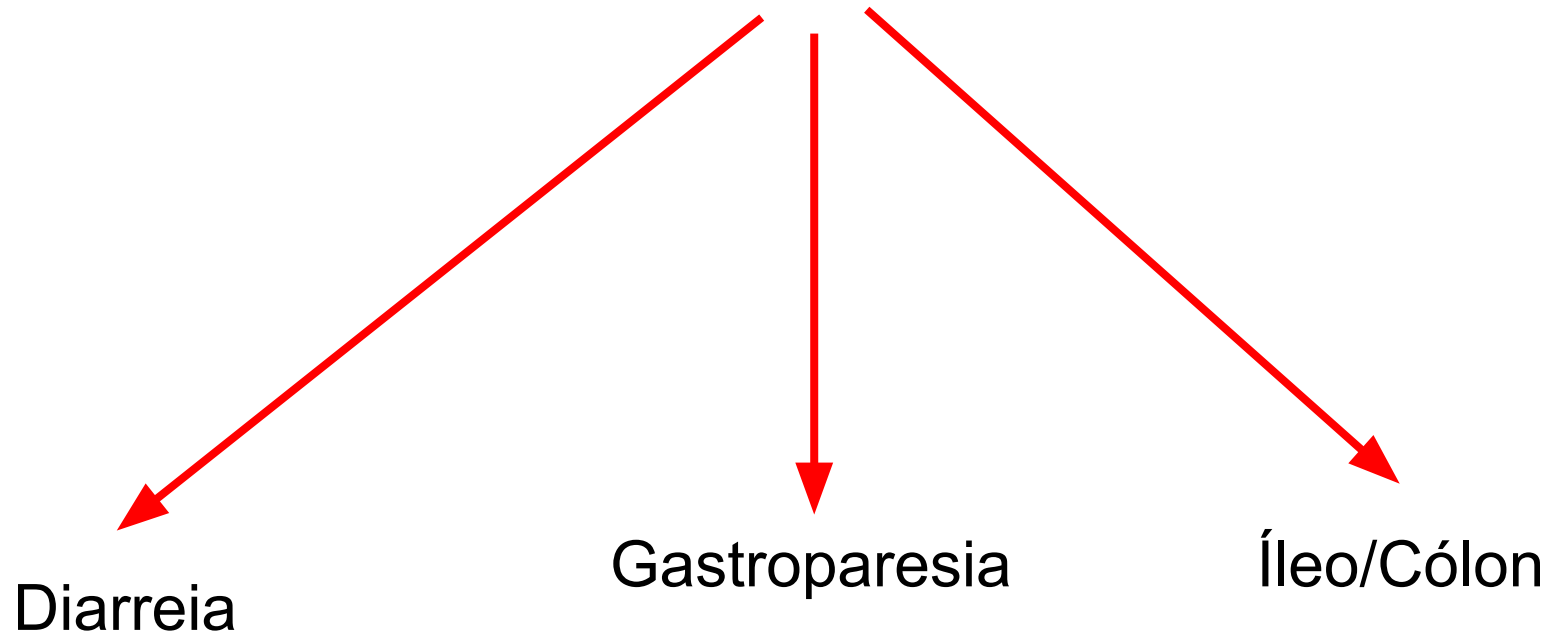
Drogas

Jejum

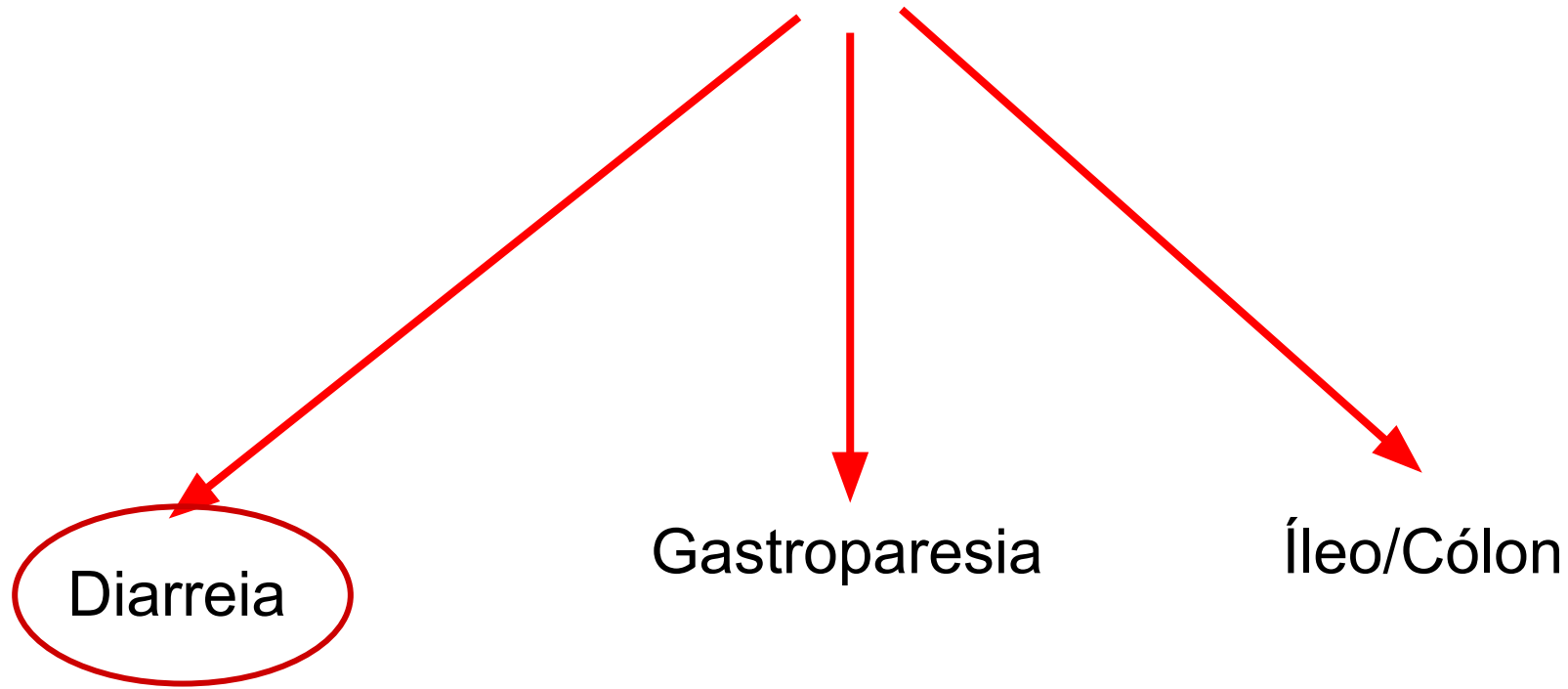
DHE



DISFUNÇÃO TGI



DISFUNÇÃO TGI



Diarréia

- 37-73% dos doentes críticos
- Infecciosas x Não Infecciosas

Definição :

- Aumento do volume (250g/dia)
- Aumento da frequência (3 ou +)
- Redução Consistência (5-7 Bristol)



Investigação de diarreia como motivo da internação :



Toxina	Cultura	PCR Fezes	Teste rápido fezes	Biópsia da mucosa	Imunoensaio enzimático
-Clostridium (pesquisa de toxina A e B) -E. coli Shiga - like toxin (teste para toxina Shiga)	- E. coli - Salmonella - Shigella - Campylobacter - Vibrio cholerae - Outros Vibrios - Aeromonas	-Norovirus -Entamoeba histolytica	-Rotavirus -Adenovirus	-CMV -Herpes virus	-Entamoeba histolytica -Cryptosporidium parvum -Microsporidium species -Isospora belli -Giardia lamblia

Paciente imunossuprimido :

- Infecções (virais, bacterianas, parasitas, fungos)
- Neoplasias (linfoma, sarcoma de Kaposi)
- Medicamentos (tacrolimus, micofenolato, antibióticos)
- Doença linfoproliferativa pós-transplante (PTLD)
- Doença enxerto vs. hospedeiro (GVHD) > Dermatite + Mucosite + Hepatite
- Colite Neutropênica



Investigação de diarreia que se iniciou na UTI :



Investigação de diarreia que se iniciou na UTI :

ORIGINAL

Diarrhea during critical illness: a multicenter cohort study



Intensive Care Med
<https://doi.org/10.1007/s00134-022-06663-8>

73% incidência

Fatores associados : tempo ATB,
dieta enteral, supositórios.

< 2% foi clostridium



Diarreia por drogas

- **Beta Lactâmicos (clavulanato e piperacilina/tazobactam);**
- Macrolídeos, quinolonas;
- Compostos com magnésio (antiácidos, magnésio via oral);
- Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs);
- Antidepressivos;
- Inibidores de bomba de prótons;
- Terlipressina.
- Laxativos...



Dieta Enteral

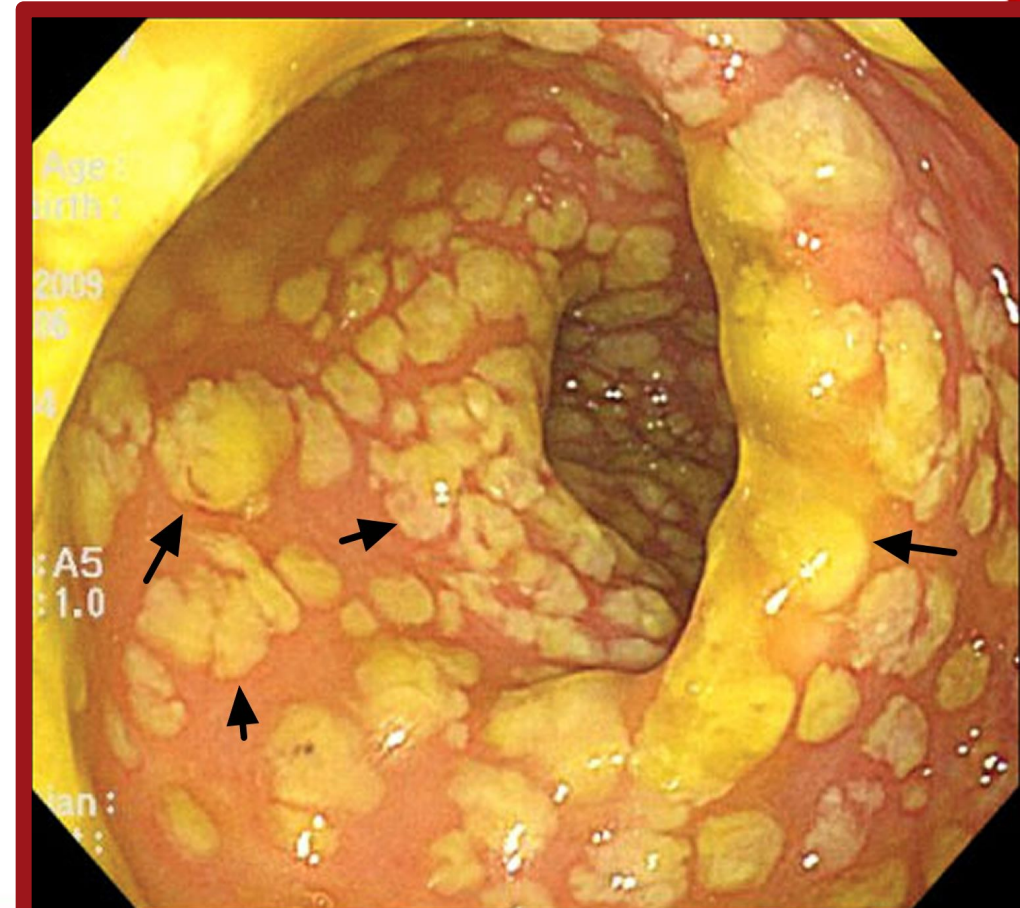
- Diagnóstico de exclusão!
- Osmolaridade ? Velocidade?



Colite pseudomembranosa

- IRAS + Comum nos EUA (250 mil/ano);
- 10-25 % das diarreias na UTI;
- 10% dos doentes críticos são colonizados por *Clostridioides difficile*.

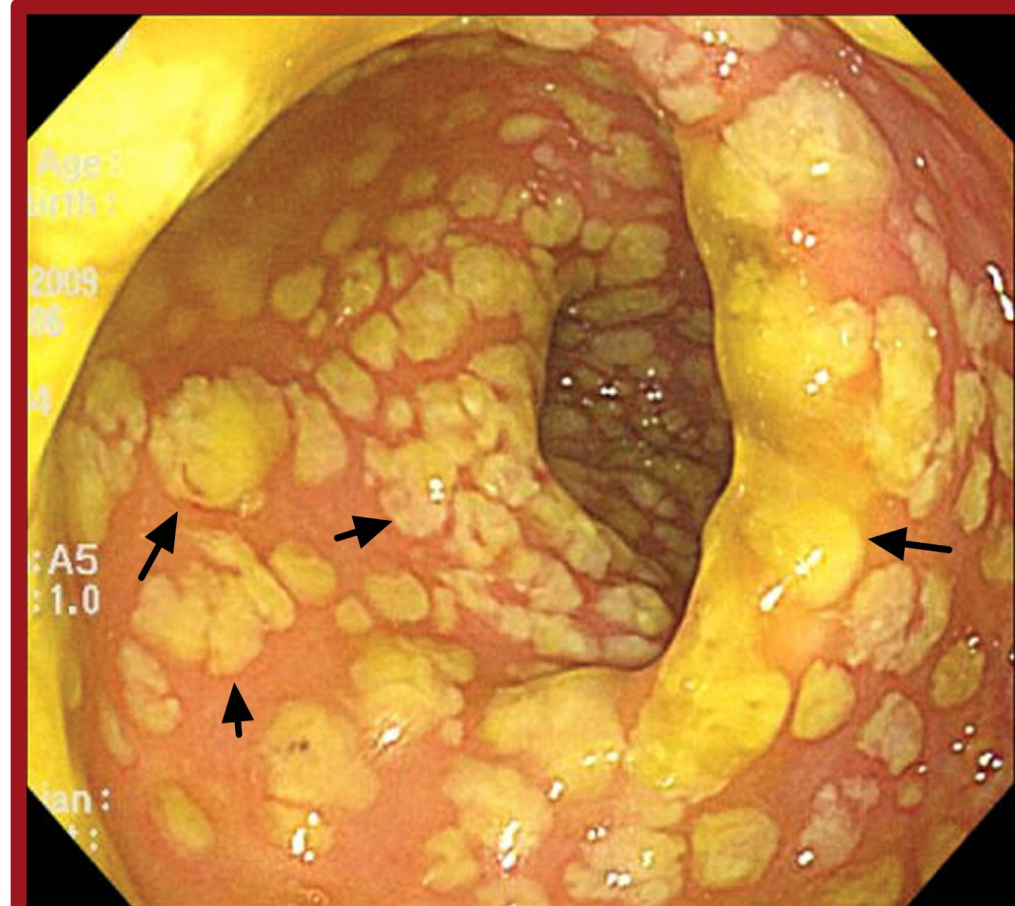
<https://healthjade.com/pseudomembranous-colitis/>



Colite pseudomembranosa

- Diarreia Leve >>>> Colite Fulminante
- Doente Crítico -> Mortalidade 20-40%

<https://healthjade.com/pseudomembranous-colitis/>



Colite pseudomembranosa

- Principal fator de risco :

Uso de antibióticos !

Clindamicina

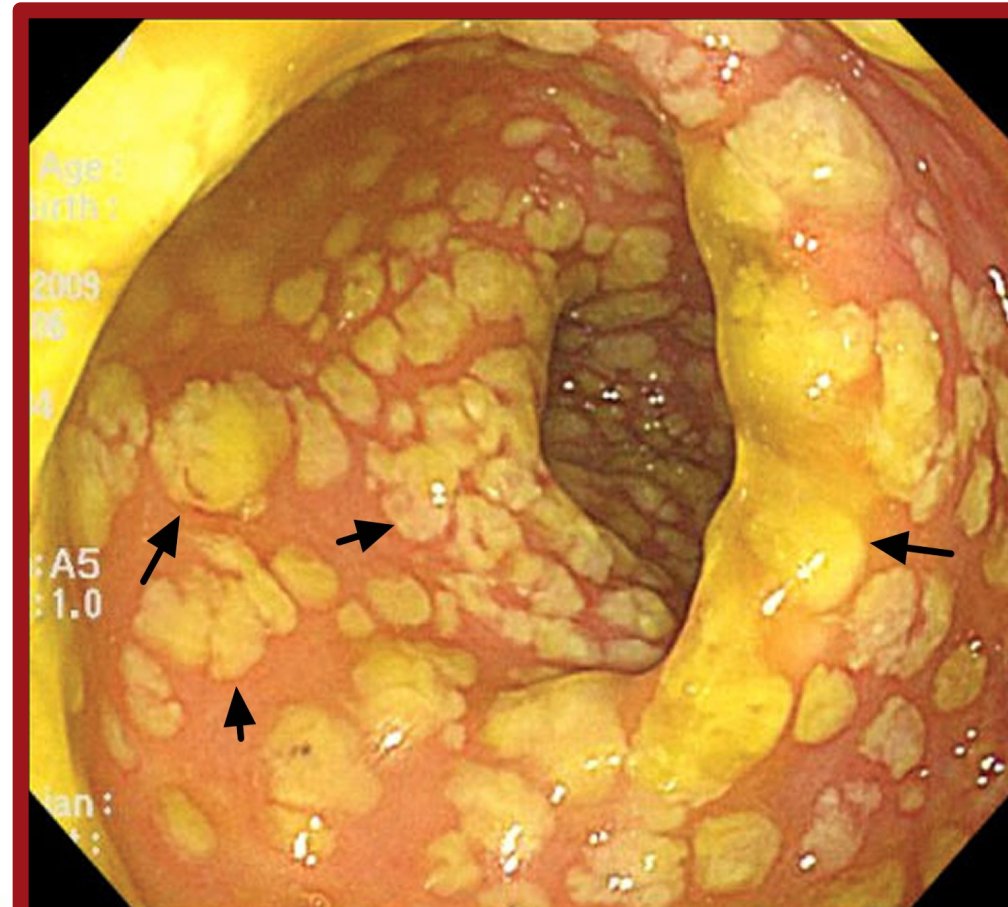
Quinolonas

Cefalosporinas (3 e 4)

Penicilinas (Piperacilina-Tazobactam)

Carbapenêmicos

<https://healthjade.com/pseudomembranous-colitis/>



Colite Pseudomembranosa - Diagnóstico

Toxinas A e B :

Detecta as toxinas / pouco sensível

GDH :

Detecta a bactéria, não necessariamente cepas
toxigênicas

PCR Clostridioides :

Padrão ouro / detecta bactéria +
cepas toxigênicas



Colite Pseudomembranosa - Gravidade

Grave :

Leucocitose > 15.000 e/ou
Cr > 1,5 (ou aumento de 50% basal)

Fulminante:

Presença de choque, íleo ou
megacólon



Colite Pseudomembranosa - Tratamento

Vanco VO (Melhor que Metro VO) - 125-500mg 6/6h, ação local

Metronidazol EV – Melhor para casos graves, em associação a Vanco

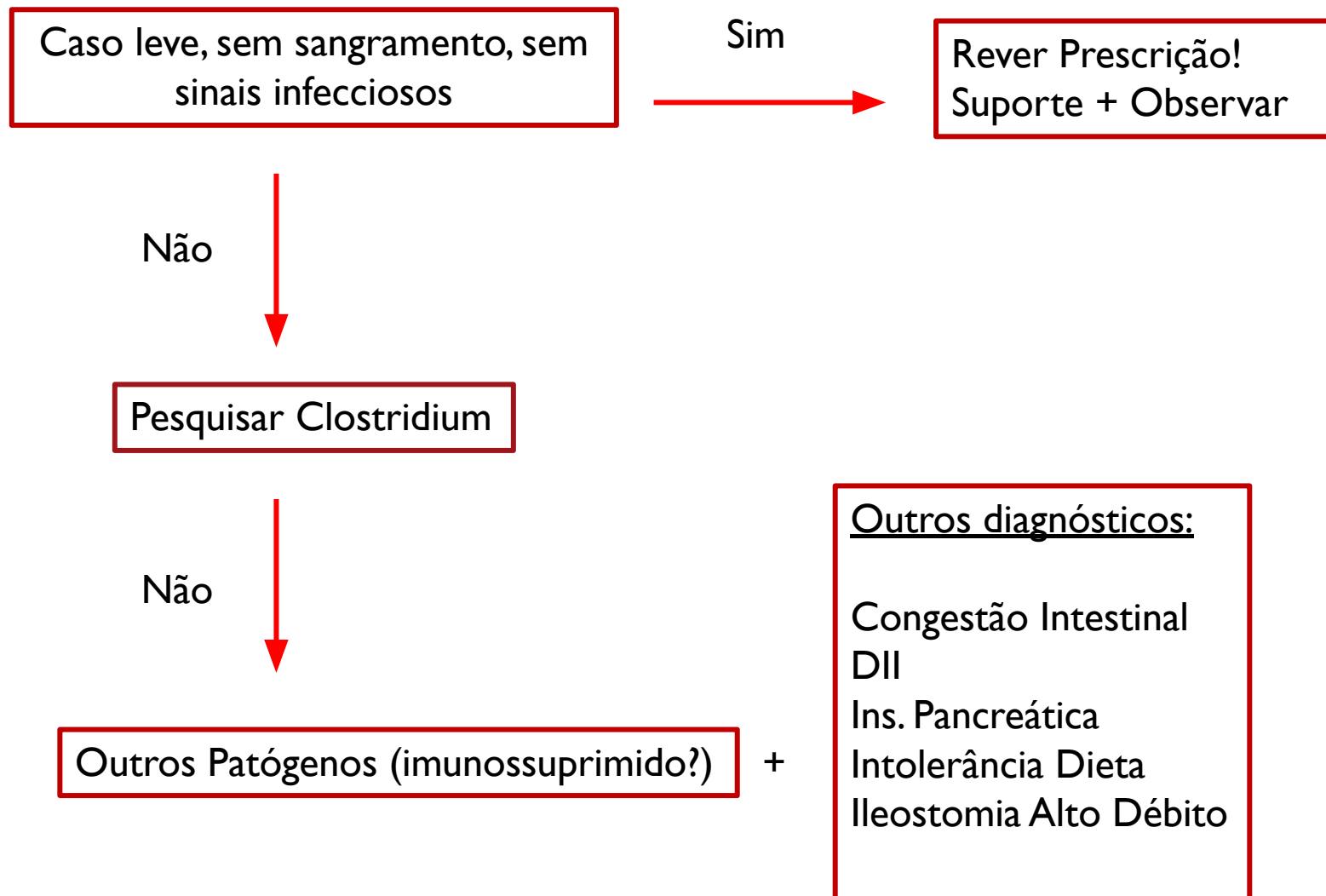
Transplante de Fezes - Casos refratários/graves

Cirurgia – 25% das fulminantes

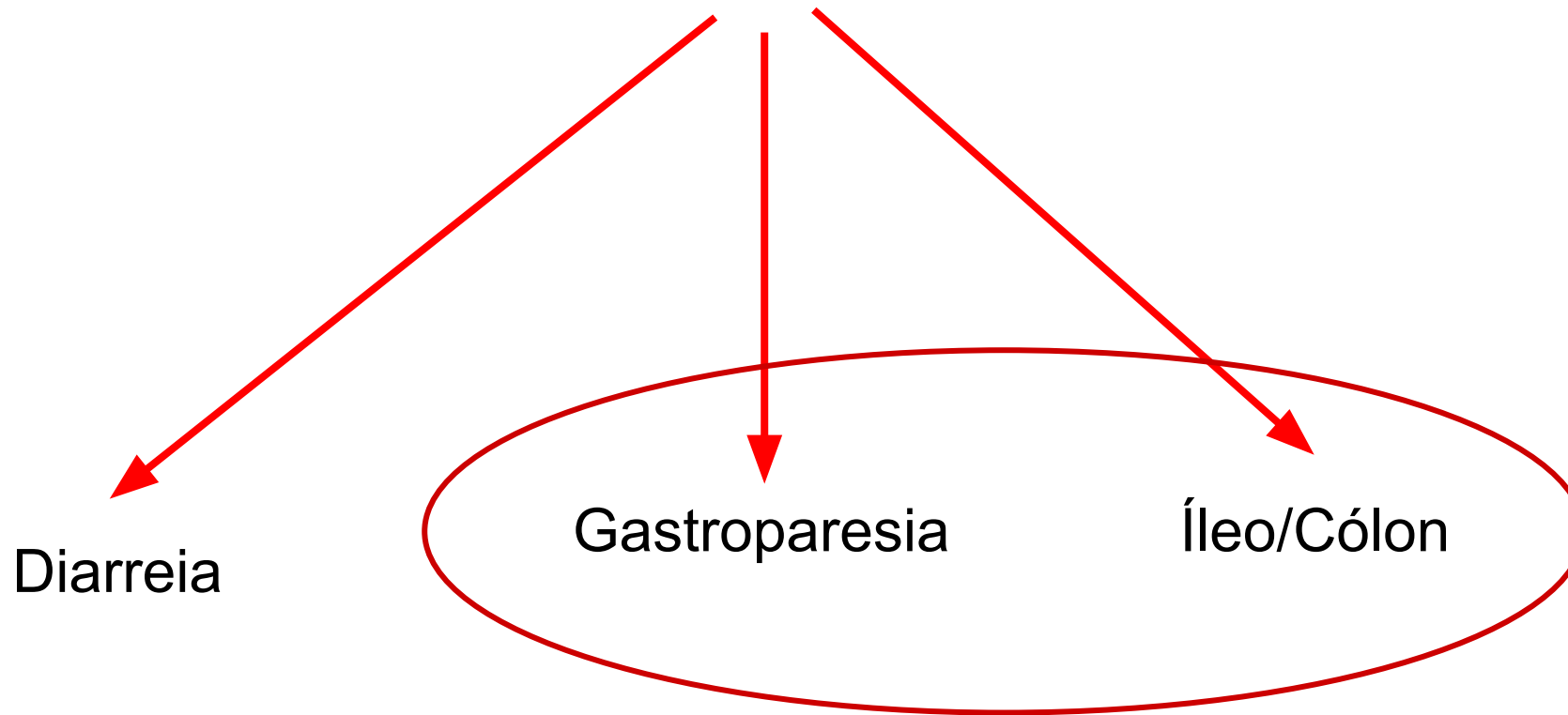
*Fidaxomicina/ Bezlotoxumab – Novas terapias



Fluxograma Diarreia na UTI



DISFUNÇÃO TGI



Gastroparesia e/ou Íleo paralítico

- 60% dos pacientes em VM
- Termos diversos : Insuficiência / Disfunção / Lesão / Injúria
- Inflamação >> Edema + Hipofluxo >> Dismotilidades

*Síndrome Ogilvie : pseudo obstrução colônica
(= íleo paralítico no intestino grosso)



Grau	Definição	Apresentação
Sem AGI	Ausência de disfunção	Sem sintomas, inicia e tolera dieta enteral > 50% da meta calórica.
AGI I (Risco)	Sintomas TGI após insulto, autolimitados	Náusea pós operatória; Ausência de ruídos abdominais por cirurgia, droga ou choque; diarreia ou distensão abdominal leve condizente com quadro.
AGI II (Disfunção)	Requer tratamento, mas sem disfunção clínica	Gastroparesia, íleo adinâmico, diarreia intensa, HIA 1 (PIA 12-15 mmHg).
AGI III (Insuficiência)	Sintomas refratários, DMOS	Gastroparesia, vômitos, aperistalse, distensão abdominal/colônica, diarreia grave, sepse complicada por peritonite/pancreatite.
AGI IV (Emergência)	Insuficiência ameaçadora à vida	Isquemia intestinal, sangramento TGI com choque, síndrome de Ogilvie, SCA que requer descompressão.

Pseudo - obstrução colônica

Detalhes importantes :

Risco de perfuração se ceco > 10 - 12 cm

Persistência > 6 dias



Gastroparesia e/ou Íleo paralítico

Sugestão de manejo !



Sem AGI

AGI I

- ✓ Garantir oferta de fluídos e eletrólitos
- ✓ Avaliar iniciar/progredir dieta enteral
- ✓ Reduzir/Suspender drogas dismotílicas
- ✓ Considerar uso precoce de laxativo
- ✓ Reavaliar a cada 6-12h

AGI II

- ✓ Considerar aferir PIA
- ✓ Considerar dieta trófica enteral

Gastroparesia

Metoclopramida
Eritromicina
Dieta Pós Pilórica ?

Paralisia
Delgado/Cólon

- ✓ Avaliar Laxativo
- ✓ Considerar Neostigmina

Diarreia

- ✓ Interromper laxativos e pró-cinéticos
- ✓ Excluir *C. difficile*
- ✓ Anamnese + Rever medicações
- ✓ Buscar e tratar Causa/Desencadeante

AGI III

- ✓ Rever Diagnósticos
- ✓ Otimizar terapia sintomática
- ✓ Tratar HIA
- ✓ Considerar dieta trófica
- ✓ Considerar NP após 4-7 dias
- ✓ Reavaliação 12/12h

AGI IV

- Intervenção é necessária!
- ✓ Consultar cirurgia, Gastro, Radiologia
- ✓ Suspender dieta enteral
- ✓ Considerar:
 - ✓ Endoscopia (colono descompressiva)
 - ✓ Radiointervenção (sangramento/coleção)
 - ✓ Laparotomia

Gastroparesia e/ou Íleo paralítico

Exemplo de evolução :



Paciente em PO colectomia
direita, iniciado dieta VO de prova

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- Suspenso dieta por náuseas e vômitos

- **Grau 1 – risco**

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- **Avaliação do risco nutricional**
- **Deambulação**
- **Antieméticos**
- **Hidratação e reposição hidroeletrólítica adequada**
- **Reiniciar dieta assim que possível**

- **Suspenso dieta por náuseas e vômitos**

- **Grau 1 – risco**

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- **Persistência dos vômitos, distensão
abdominal, RHA abolidos**

Grau 2 – disfunção

- **Suspenso dieta por náuseas e vômitos**

- **Grau 1 – risco**

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- **Persistência dos vômitos, distensão
abdominal, RHA abolidos**

Grau 2 – disfunção

- **Suspenso dieta por náuseas e vômitos**

- **Grau 1 – risco**

- **Procinéticos**
- **SNG e medir resíduo gástrico**
- **Avaliar SNE pós-pilórica**
- **Avaliar PIA**

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- **Persistência dos vômitos, distensão
abdominal, RHA abolidos**

Grau 2 – disfunção



- Paciente continua em dieta zero oral, já
em uso de 2 drogas procinéticas,
mantendo distensão abdominal, ausência
de eliminações intestinais. PIA 21mmHg

Grau 3 – insuficiência

- **Suspenso dieta por náuseas e vômitos**

- **Grau 1 – risco**

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- **Persistência dos vômitos, distensão
abdominal, RHA abolidos**

Grau 2 – disfunção



- Paciente continua em dieta zero oral, já
em uso de 2 drogas procinéticas,
mantendo distensão abdominal, ausência
de eliminações intestinais. PIA 21mmHg

Grau 3 – insuficiência

- Suspenso dieta por náuseas e vômitos

- **Grau 1 – risco**

- **Afastar complicação intra-abdominal**
- **Avaliar nutrição parenteral**

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- Suspenso dieta por náuseas e vômitos

- **Grau 1 – risco**

- **Persistência dos vômitos, distensão abdominal, RHA abolidos**

Grau 2 – disfunção



- Paciente continua em dieta zero oral, já em uso de 2 drogas procinéticas, mantendo distensão abdominal, ausência de eliminações intestinais. PIA 21mmHg

Grau 3 – insuficiência



- **Distensão abdominal, choque circulatório, isquemia mesentérica não oclusiva**

- **PIA 25mmHg**

Grau 4 – insuficiência com risco de vida

Paciente no 5 dia ARDS por pneumonia,
ETOT ha 24 horas, dieta VO de prova



- **Sem queixas**

Grau 0 – sem AGI



- Suspenso dieta por náuseas e vômitos

- **Grau 1 – risco**

- **Persistência dos vômitos, distensão
abdominal, RHA abolidos**

Grau 2 – disfunção



- Paciente continua em dieta zero oral, já
em uso de 2 drogas procinéticas,
mantendo distensão abdominal, ausência
de eliminações intestinais. PIA 21mmHg

Grau 3 – insuficiência



- **Distensão abdominal, choque circulatório,
isquemia mesentérica não oclusiva**

- **PIA 25mmHg**

Grau 4 – insuficiência com risco de vida

**C
I
R
U
R
G
I
A
?**

Obrigada

Dúvidas :

gastrointensiva@gmail.com

